HASTA EVET DER™ · ANA MATERYAL

# 40 Vaka Tipi İçin Hasta Sunum Metni

Muayeneden sonra planı hastaya ya da ebeveyne sade, dürüst ve baskısız anlatmak için 40 vaka tipine hazır konuşma metni.

Ortodontistin Başucu Kitabı

# İçindekiler

1 · Nasıl kullanılır ve etik sunumun ilkeleri

2 · Sınıf I ve Yer Problemleri (Vaka 01–08)

3 · Sınıf II Vakaları (Vaka 09–16)

4 · Sınıf III Vakaları (Vaka 17–21)

5 · Vertikal ve Transversal Problemler (Vaka 22–28)

6 · Diş Sayısı ve Diş Konumu (Vaka 29–34)

7 · Erişkin ve Özel Durumlar (Vaka 35–40)

8 · Sunum sonrası kontrol listesi

BÖLÜM 1

# Nasıl Kullanılır

Her vaka tek sayfa: önce çerçeveye bakın, sonra metni kendi cümlelerinizle söyleyin.

> *Bu metinler ezberlenecek bir senaryo değildir. Hastanın kayıtlarını gördükten sonra, size uyan sözcüklerle anlatmanız için bir iskelettir.*

1. **Vaka tipini bulun.** İçindekilerden veya bölüm başındaki tablodan en yakın vaka tipini seçin. Birden fazla problem varsa önce hastanın şikâyetine en yakın olanı kullanın.
2. **Klinik çerçeveyi okuyun.** Kutudaki bilgi size yöneliktir; hastaya okunmaz. Kendi bulgularınızla uyuşmayan cümleyi metinden çıkarın.
3. **Metni sade dille söyleyin.** Teknik terim kullanmanız gerekirse hemen ardından günlük dildeki karşılığını verin.
4. **Aparey veya çekimi ayrıca anlatın.** Bu bilgi, ana metinden sonra ve hastanın soru sorabileceği bir aralık bıraktıktan sonra gelmelidir.
5. **Kaçınılacak ifadelere dikkat edin.** Sağ sütundaki cümleler aynı bilgiyi baskı ve vaat olmadan verir.
6. **Anlaşıldığını kontrol edin.** «Size anlattıklarımı kendi cümlelerinizle özetler misiniz?» diye sorun. Kararı aynı gün beklemeyin.

| ETİK SUNUMUN 6 İLKESİ | UYGULAMADA |
|---|---|
| 1 · Önce dinleyin | Hastanın ya da ebeveynin şikâyetini ve beklentisini kendi sözcükleriyle alın; plana oradan başlayın. |
| 2 · Gördüğünüzü anlatın, yargılamayın | «Çarpık», «bozuk», «kötü» yerine «önde», «sıkışık», «ters kapanıyor» gibi tarif edici sözcükler. |
| 3 · Seçenekleri sunun | Uygun olan her seçeneği; tedavi etmemek ve izlemek dahil. Önerinizi ve nedenini ayrıca söyleyin. |
| 4 · Vaat etmeyin | Süre için yaklaşık aralık; sonuç için hedef. «Kesin», «garanti», «mükemmel» sözcükleri yok. |
| 5 · Hastanın görevini açıkça söyleyin | Ağız hijyeni, elastik veya aparey kullanımı, kontrollere gelme ve pekiştirme. |

| ETİK SUNUMUN 6 İLKESİ | UYGULAMADA |
|---|---|
| 6 · Karar için zaman tanıyın | Aynı gün karar beklemeyin. Yazılı planı ve kliniğinizin kullandığı onam formunu eve götürmesine izin verin. |

## Her sunumun 5 parçalı iskeleti

| PARÇA | SORU | ÖRNEK AÇILIŞ |
|---|---|---|
| 1 · Gördüğüm | Ne buldum? | «Muayenede ve kayıtlarda şunu görüyoruz...» |
| 2 · Neden önemli | Tedavi edilmezse ne olabilir? | «Bu durum zamanla şunlara yol açabilir...» |
| 3 · Ne öneriyorum | Hedef ve yöntem | «Amacımız... Bunun için önerdiğim yol...» |
| 4 · Seçenekler | Başka yollar ve sınırları | «Diğer seçenekler de var; artıları ve sınırları şunlar...» |
| 5 · Sizin rolünüz ve sonraki adım | Hasta ne yapacak? | «Sizden beklenen... Bir sonraki adımımız...» |

> **Tüm vakalarda geçerli: söylemeyin**
> «Garanti ediyorum», «hiç acımaz», «bugün karar verirseniz», «başka hekim yanlış söylemiş», «çok kolay bir vaka», «kesin şu kadar ayda biter», «ameliyata gerek kalmaz» gibi ifadeler beklenti yaratır ve güveni zedeler.

BÖLÜM 2

# Sınıf I ve Yer Problemleri

Çene ilişkisi dengeli; sorun dizilişte, yerde ve boşluklarda.

*Bu bölümde Vaka 01–08 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 01 | Sınıf I, hafif çapraşıklık | Hasta (erişkin) | Kapanış dengeli, sorun diziliş |
| 02 | Sınıf I, orta çapraşıklık | Ergen ve ebeveyn | Yer açılacak, yöntemi birlikte seçilecek |
| 03 | Sınıf I, şiddetli çapraşıklık | Hasta veya ebeveyn | Belirgin yer eksikliği; çekim seçeneği gerekçesiyle |
| 04 | Bimaksiller protrüzyon | Hasta (ergen veya erişkin) | Dişler ve dudaklar önde; amaç dengeyi konuşmak |
| 05 | Orta hat diastemi (erişkin) | Hasta (erişkin) | Boşluğun nedeni bulunmadan kapatma yok |
| 06 | Genel aralıklı dişler | Hasta | Boşlukların nedeni ve ne yapılacağı birlikte |
| 07 | Orta hat kayması | Hasta | Kaymanın kaynağı dişte mi çenede mi |
| 08 | Karma dişlenmede çapraşıklık (çocuk) | Ebeveyn | Şimdi izlem mi, şimdi müdahale mi |

# Sınıf I, hafif çapraşıklık

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Kapanış dengeli, sorun diziliş**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Molar ve kanin ilişkisi Sınıf I, iskelet yapı uyumlu. Ön bölgede hafif çapraşıklık; IPR veya sınırlı ark gelişimiyle çözüm öngörülüyor.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Muayenenizde çene ilişkiniz ve kapanışınız genel olarak dengeli görünüyor. Sorun daha çok dişlerin dizilişinde: özellikle ön dişlerde hafif bir sıkışıklık var. Bu sıkışıklık dişlerin arasını temizlemeyi zorlaştırabilir ve yıllar içinde biraz artabilir. Tedavideki amacımız, dişleri kemik içinde düzgün bir sıraya koymak ve şu anki iyi kapanışınızı korumak. Bu tür vakalarda çoğu zaman diş çekimine gerek kalmaz. Süre için bugün kesin bir rakam vermem doğru olmaz; yaklaşık bir aralık söyleyebilirim, ilk kontrollerden sonra daha net konuşuruz. Tedavi bittiğinde pekiştirme aparatı kullanmak, sonucun korunması için tedavinin bir parçasıdır. Karar vermeden önce aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

IPR gerekiyorsa: «Dişlerin yan yüzeylerinden çok ince, ölçülü bir mine tabakası alınır. Böylece dişleri çekmeden küçük bir yer kazanırız. Genellikle uyuşturma gerektirmez; ne kadar yapılacağını önceden planlarız.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu çok basit, hemen biter. | ✓ Planı net bir vaka; süreyi ilk kontrollerden sonra netleştiririz. |
| ✗ Dişlerinizi törpüleyeceğiz. | ✓ Yan yüzeylerden ölçülü, çok ince bir düzeltme yapılır. |
| ✗ Pekiştirme şart değil. | ✓ Pekiştirme, tedavinin son ve kalıcı aşamasıdır. |

# Sınıf I, orta çapraşıklık

**Kime: Ergen ve ebeveyn** **Ana mesaj: Yer açılacak, yöntemi birlikte seçilecek**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Sınıf I ilişki, orta düzeyde çapraşıklık. Yer analizine göre genişletme, IPR veya çekim seçenekleri tartışılabilir; profil ve dişeti dokusu belirleyici.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Çenelerin birbirine göre konumu dengeli, ancak dişler için ayrılan yer, dişlerin toplam genişliğinden biraz az. Bu yüzden bazı dişler öne, arkaya ya da dönmüş şekilde çıkmış. Dişleri düzgün dizmek için önce yer açmamız gerekiyor. Yer açmanın birkaç yolu var: diş arkını kontrollü biçimde genişletmek, dişlerin yan yüzeylerinden çok az mine almak ya da bazı vakalarda diş çekmek. Hangisinin uygun olduğuna yüz profili, dudak desteği ve dişeti dokusu birlikte bakarak karar veriyoruz. Bugün size seçenekleri ve her birinin artısını, eksisini anlatacağım. Hangi yolu seçersek seçelim, düzenli kontrol, iyi ağız temizliği ve tedavi sonrası pekiştirme başarının temelidir.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

Çekim gündeme gelirse: «Çekim, yer açmanın yollarından sadece biridir. Önerirsem nedenini kayıtlar üzerinde size gösteririm: yer ihtiyacı ve profiliniz. Kararı birlikte veririz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Çekim yapmazsak olmaz. | ✓ Seçenekleri ve her birinin sonucunu birlikte değerlendirelim. |
| ✗ Arkadaşınızınki gibi olacak. | ✓ Her vakanın planı kendi kayıtlarına göre yapılır. |
| ✗ Biraz yer açarız, o kadar. | ✓ Yer açmanın üç yolu var; size uygun olanı birlikte seçeceğiz. |

# Sınıf I, şiddetli çapraşıklık

**Kime: Hasta veya ebeveyn** **Ana mesaj: Belirgin yer eksikliği; çekim seçeneği gerekçesiyle**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Belirgin yer yetersizliği; kanin dışarıda veya dişler üst üste. Yer analizi ve profil değerlendirmesine göre çekimli plan güçlü bir seçenek.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Ağzınızdaki dişlerin toplam genişliği, çenenin taşıyabileceği yerden belirgin biçimde fazla. Bu nedenle bazı dişler sıranın dışında kalmış. Bu kadar yer ihtiyacı olduğunda, dişleri yalnızca genişleterek dizmek; dişleri kemiğin dışına ya da dudakları öne itebilir. Bu, hem dişeti sağlığı hem de sonucun kalıcılığı açısından risk taşır. Bu yüzden sizin vakanızda bazı dişlerin çekilmesini bir seçenek olarak masaya koyuyorum. Bu kararı kolay vermiyoruz; kayıtlar, yüz profiliniz ve diş eti durumunuz birlikte değerlendirildi. Çekimsiz bir yolun artılarını ve sınırlarını da size açıkça anlatacağım. Sonunda karar sizinle birlikte verilecek.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Çekim genellikle küçük azı dişlerinden yapılır; açılan boşluk tedavi sırasında dişler kaydırılarak kapatılır. Tedavi sonunda ağızda boşluk kalması hedeflenmez. Çekimi hangi hekimin ve ne zaman yapacağını planlayıp size yazılı olarak veririz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Dört diş çekeceğiz, başka yolu yok. | ✓ Kayıtlarınıza göre çekimli plan güçlü bir seçenek; diğer yolları da anlatacağım. |
| ✗ Çekim yüzünüzü kesin bozmaz. | ✓ Planı profilinizi dikkate alarak yapıyoruz; bunu kayıtlarla birlikte konuşalım. |
| ✗ Sonra boşluk kalabilir ama önemli değil. | ✓ Boşlukların tedavi içinde kapatılması planlanır. |

# Bimaksiller protrüzyon

**Kime: Hasta (ergen veya erişkin)** **Ana mesaj: Dişler ve dudaklar önde; amaç dengeyi konuşmak**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst ve alt kesiciler önde, dudaklar dolgun ve kapatmakta zorlanıyor olabilir. Profil ve hasta beklentisi çekim kararında belirleyici.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ve alt ön dişleriniz, çene kemiğine göre biraz öne eğimli duruyor. Bu durum dudakların da önde görünmesine ve dudakları kapatırken zorlanmanıza yol açabilir. Önce şunu sormak istiyorum: profilinizde sizi rahatsız eden bir şey var mı? Bu sorunun cevabı planı değiştirir. Eğer amaç ön dişleri geriye almaksa, bunun için yer gerekir ve bu yer çoğu zaman diş çekimiyle sağlanır. Eğer profilinizden memnunsanız, dişleri mevcut eğimde düzgünleştiren daha sınırlı bir plan da konuşulabilir. Her iki yolun da artılarını ve sınırlarını kayıtlar üzerinde göstereceğim. Dudak ve yüz görünümündeki değişim kişiden kişiye farklıdır; bunu önceden kesin söylemek mümkün değildir.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Ön dişleri geriye alabilmek için arkada yer açmamız gerekir. Bu yer çoğunlukla küçük azı dişlerinin çekimiyle sağlanır. Gerekirse arka dişlerin öne kaymaması için mini vida gibi ek destekler kullanabiliriz; bunu ayrıca anlatırım.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Dudaklarınız çok çıkık. | ✓ Dudaklar dişlerin eğimi nedeniyle biraz önde duruyor; sizi rahatsız ediyor mu? |
| ✗ Yüzünüz tamamen değişecek. | ✓ Yüzdeki değişim kişiye göre farklıdır; beklentimizi birlikte netleştirelim. |
| ✗ Çekim yapmazsak tedavi anlamsız. | ✓ Çekimli ve çekimsiz planların neler sağlayacağını yan yana konuşalım. |

# Orta hat diastemi (erişkin)

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Boşluğun nedeni bulunmadan kapatma yok**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst orta kesiciler arasında boşluk. Frenulum, diş boyutu uyumsuzluğu, kesici eğimi, eksik diş veya periodontal neden değerlendirilmeli.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Ön iki dişiniz arasındaki boşluğu kapatmak mümkün, ancak önce boşluğun neden oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Bazen dudağın iç tarafındaki bağın dişler arasına uzanması, bazen dişlerin yan dişlere göre küçük olması, bazen de dişlerin öne doğru eğimli durması buna yol açar. Diş eti ve kemik desteği de bu değerlendirmenin parçası. Nedeni belirledikten sonra boşluğu ortodontik olarak kapatabilir, gerekirse diş hekiminizle birlikte dişlerin şeklini de düzenleyebiliriz. Bu tür boşluklar kapatıldıktan sonra yeniden açılma eğilimi gösterebilir. Bu yüzden ön dişlerin arka yüzüne ince bir sabit pekiştirme teli yapıştırmayı ve uzun süre korumayı öneriyorum.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

Frenektomi veya restoratif destek gerekirse: «Bağ dokusunun küçük bir işlemle düzeltilmesi ya da dişlerin şeklinin dolguyla genişletilmesi gerekebilir. Bunun sırasını ve kimin yapacağını size ayrıca açıklarım.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ İki ayda kapatırız, olur biter. | ✓ Önce nedeni bulalım; sonra süreyi ve yöntemi konuşalım. |
| ✗ Kapanınca bir daha açılmaz. | ✓ Bu boşluklar yeniden açılmaya eğilimlidir; bu yüzden pekiştirme önemli. |
| ✗ Diş eti sorunu sizin suçunuz. | ✓ Diş eti sağlığınızı birlikte değerlendirip koruyacağız. |

# Genel aralıklı dişler

Kime: Hasta | Ana mesaj: Boşlukların nedeni ve ne yapılacağı birlikte

**Klinik çerçeve (hekim için):** Birden fazla diş arası boşluk; diş boyutu uyumsuzluğu, dil konumu, kesici protrüzyonu veya periodontal migrasyon olası nedenler.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Dişlerinizin birçoğunun arasında boşluklar var. Bu genellikle dişlerin çeneye göre küçük kalması, dilin dişlere baskı yapması ya da dişlerin öne doğru yelpazelenmesiyle olur. Diş eti ve kemik durumunuzu da kontrol ettik; çünkü bazen boşluklar diş eti hastalığına bağlı olarak sonradan açılır. Tedavide boşlukları kapatırken ön dişlerin eğimini de düzeltebiliriz. Bazı vakalarda tüm boşlukları kapatmak yerine dişlerin şeklini dolguyla düzenlemek için alan bırakmak daha estetik bir sonuç verir; bunu diş hekiminizle birlikte planlarız. Boşluklu vakalarda pekiştirme özellikle önemlidir. Dil alışkanlığı varsa, bunun farkında olmanız da sonucun korunmasına yardım eder.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bazı boşlukları tamamen kapatmak yerine, dişlerin şeklini düzenlemek için ölçülü bir alan bırakabiliriz. Bu kararı gülüşünüzdeki diş oranlarına bakarak birlikte veririz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Diliniz yüzünden bozulmuş. | ✓ Dilin konumu boşlukları etkileyebilir; bunu birlikte takip edeceğiz. |
| ✗ Hepsini kapatırız, hiç sorun değil. | ✓ Hangi boşlukları kapatacağımızı diş oranlarınıza göre planlayalım. |
| ✗ Pekiştirmeye gerek kalmaz. | ✓ Boşluklu vakalarda pekiştirme sonucun korunması için gereklidir. |

# Orta hat kayması

Kime: Hasta | Ana mesaj: Kaymanın kaynağı dişte mi çenede mi

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst ve/veya alt orta hat yüz orta hattına göre kaymış. Dental kayma mı, fonksiyonel kayma mı, iskeletsel asimetri mi ayırt edilmeli.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ve alt ön dişlerinizin ortası, yüzünüzün ortasıyla tam aynı hizada değil. Bunun birkaç olası nedeni var: dişlerin kendisinin kaymış olması, çene kapanırken bir yöne kayması ya da daha nadiren çene kemiğinin kendisindeki bir asimetri. Muayenede ve kayıtlarda hangisi olduğunu ayırt etmeye çalıştık. Dişlere bağlı kaymalar çoğu zaman ortodontik tedaviyle iyileştirilebilir. Çene kemiğinden kaynaklanan bir fark varsa, ne kadarını düzeltebileceğimizi açıkça söylemem gerekir. Bazen orta hattı tam ortalamak, kapanışı bozma pahasına olur; böyle bir durumda öncelik sağlıklı ve dengeli bir kapanıştır. Tedavi hedefini birlikte, gerçekçi biçimde belirleyelim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

Asimetrik mekanik veya ek destek gerekirse: «Bir taraftaki dişleri diğerinden farklı hareket ettirmek için elastik veya mini vida gibi destekler kullanabiliriz. Bunların nasıl kullanılacağını adım adım göstereceğim.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Orta hattı milimetrik ortalarız. | ✓ Hedefimiz dengeli kapanış; orta hatta ne kadar ilerleyeceğimizi birlikte konuşalım. |
| ✗ Çeneniz yamuk. | ✓ Kayıtlarda iki taraf arasında küçük bir fark görüyoruz; ne anlama geldiğini anlatayım. |
| ✗ Kimse fark etmez zaten. | ✓ Sizin için önemli olan bu ise, hedefe dahil edelim. |

# Karma dişlenmede çapraşıklık (çocuk)

Kime: Ebeveyn | Ana mesaj: Şimdi izlem mi, şimdi müdahale mi

**Klinik çerçeve (hekim için):** Karma dişlenme dönemi, ön bölgede çapraşıklık. Yer analizi, süt dişlerinin durumu ve sürme sırası izlem veya sınırlı müdahale kararını belirler.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun ağzında şu anda hem süt hem kalıcı dişler var. Ön dişlerde gördüğünüz sıkışıklık, bu dönemde sık karşılaşılan bir durumdur ve bir kısmı çene büyüdükçe ve süt dişleri değiştikçe azalabilir. Ancak yer eksikliği belirginse, bazı basit önlemlerle ilerideki tedaviyi kolaylaştırmak mümkün olabilir. Bugünkü kayıtlara göre size ya düzenli izlem ya da sınırlı bir müdahale önereceğim ve nedenini açıklayacağım. İzlemde kalırsak bunun «hiçbir şey yapmamak» olmadığını belirtmek isterim; belirli aralıklarla kontrol edip dişlerin sürüşünü takip edeceğiz. Süt dişlerinin çürükten korunması da önemli; çünkü erken kaybedilen süt dişi, kalıcı dişin yerini daraltabilir. Sorularınızı ve çocuğunuzun düşüncelerini de dinlemek isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

Yer tutucu veya sınırlı aparey gerekirse: «Bu aparey, kalıcı dişlerin çıkacağı yeri korumak veya biraz genişletmek için kullanılır. Kalıcı tedavi değildir; ilerideki tedaviyi kolaylaştırmayı amaçlar.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Beklersek dişleri kesin bozulur. | ✓ Bazı sıkışıklıklar kendiliğinden azalabilir; düzenli kontrolle izleyeceğiz. |
| ✗ Şimdi başlarsak sonra tel gerekmez. | ✓ Erken önlem ileriki tedaviyi kolaylaştırabilir; ileride tedavi gerekebileceğini de bilmelisiniz. |
| ✗ Çok erken, bir şey yapılmaz. | ✓ Bu dönemi kontrol randevularıyla izlemek de bir tedavi planıdır. |

BÖLÜM 3

# Sınıf II Vakaları

Çocuk, ergen ve erişkinde Sınıf II; büyüme fırsatı ve kamuflajın sınırları.

*Bu bölümde Vaka 09–16 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 09 | Sınıf II bölüm 1, çocuk | Ebeveyn | Büyüme bir fırsat; uyum belirleyici |
| 10 | Sınıf II bölüm 1, ergen | Ergen ve ebeveyn | Büyüme atılımı dönemini iyi kullanmak |
| 11 | Sınıf II bölüm 1, erişkin | Hasta (erişkin) | Büyüme yok; kamuflaj sınırlarıyla |
| 12 | Sınıf II, erişkin, cerrahi sınırda | Hasta (erişkin) | Kamuflaj ile cerrahi arasında dürüst karşılaştırma |
| 13 | Sınıf II bölüm 2, çocuk | Ebeveyn | Dik kesiciler ve derin kapanış; izlem veya erken düzeltme |
| 14 | Sınıf II bölüm 2, erişkin | Hasta (erişkin) | Derin kapanışın diş ve diş eti üzerindeki etkisi |
| 15 | Dental Sınıf II, iskelet uyumlu | Hasta | Sorun çene değil diş konumu; distalizasyon seçeneği |
| 16 | Artmış overjet, travma riski (çocuk) | Ebeveyn | Öndeki dişler darbelere açık |

# Sınıf II bölüm 1, çocuk

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Büyüme bir fırsat; uyum belirleyici**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Büyüme dönemindeki çocuk; artmış overjet, alt çene geride görünümü. Fonksiyonel aparey veya izlem seçenekleri; uyum ve büyüme dönemi belirleyici.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun üst ön dişleri alt dişlerin epey önünde duruyor. Kayıtlarda bunun önemli bir kısmının alt çenenin üst çeneye göre geride kalmasıyla ilgili olduğunu görüyoruz. Çocuğunuz hâlâ büyüme döneminde ve bu bize bir imkân sunuyor: bazı apareylerle büyümenin yönünü desteklemeye çalışabiliriz. Bu apareylerin işe yaraması büyük ölçüde düzenli kullanıma bağlı; yani çocuğunuzun ve sizin katkınız sonucun parçası. Büyümenin ne kadar katkı sağlayacağını önceden kesin bilemeyiz; bu yüzden ilerleyişi kontrollerde ölçerek takip ederiz. Bu aşamadan sonra dişleri düzenlemek için sabit tedavi gerekebilir. Hangi zamanlamanın uygun olduğunu birlikte konuşalım.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Fonksiyonel aparey, alt çeneyi biraz önde tutarak çalışan bir aparattır. İlk günlerde konuşmak ve yemek biraz garip gelebilir; çoğu çocuk birkaç haftada alışır. Ne kadar süre takılacağını size yazılı olarak vereceğim.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu aparatla çene kesin öne gelir. | ✓ Büyümeyi desteklemeyi amaçlıyoruz; etkisini kontrollerde ölçeceğiz. |
| ✗ Takmazsa sizin suçunuz. | ✓ Düzenli kullanım için birlikte bir rutin kuralım. |
| ✗ Sonrasında tele gerek kalmaz. | ✓ Bu aşamadan sonra sabit tedavi gerekebilir; bunu baştan bilmenizi isterim. |

# Sınıf II bölüm 1, ergen

**Kime: Ergen ve ebeveyn** **Ana mesaj: Büyüme atılımı dönemini iyi kullanmak**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Büyüme atılımı döneminde veya yakınında ergen; artmış overjet. Sabit tedavi ile birlikte fonksiyonel destek, Sınıf II elastikleri veya çekimli plan seçenekleri.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ön dişlerin alt dişlerin önünde kalması hem görünümü hem de ön dişlerin darbelere karşı korumasız olmasını etkiliyor. Çocuğunuz şu an büyümenin hızlı olduğu bir dönemde; bu dönem, alt ve üst çene arasındaki farkı tedaviyle birlikte ele almak için önemli bir fırsat olabilir. Planımızda dişleri düzenleyen sabit tedavinin yanında, çeneler arasındaki ilişkiyi düzeltmeye yardım eden elastikler veya aparatlar olabilir. Bunların etkisi büyük ölçüde düzenli kullanıma bağlı; bu yüzden hem sizin hem de evdeki desteğin rolü büyük. Bazen bu yol yeterli olmaz ve diş çekimiyle bir kamuflaj planı gündeme gelebilir; bu seçeneği de baştan açıkça konuşmak istiyorum. Sorularınızı, hem siz hem aileniz, rahatça sorabilirsiniz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Sınıf II elastikleri, üst ve alt teller arasına takılan küçük lastiklerdir. Her gün sizin tarafınızdan değiştirilir. İlk günlerde dişlerde baskı hissi olabilir; bu genellikle birkaç gün içinde azalır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Elastikleri takmazsanız tedavi uzar, sonra bana gelmeyin. | ✓ Elastikleri düzenli takmak bitişe giden yolu kısaltır; takamadığınız günleri bana söyleyin, birlikte çözelim. |
| ✗ Çeneyi tamamen düzelteceğiz. | ✓ Çeneler arasındaki farkı azaltmayı hedefliyoruz; ne kadar ilerlediğimizi ölçeceğiz. |
| ✗ Büyüme bitti, artık geç. | ✓ Büyüme durumunu kayıtlarla değerlendirip seçenekleri konuşacağız. |

# Sınıf II bölüm 1, erişkin

Kime: Hasta (erişkin) | Ana mesaj: Büyüme yok; kamuflaj sınırlarıyla

**Klinik çerçeve (hekim için):** Büyümesi tamamlanmış erişkin; Sınıf II ilişki, artmış overjet. Seçenekler: dişsel kamuflaj (çekimli veya distalizasyon), cerrahi ile kombine tedavi veya sınırlı tedavi.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ön dişleriniz alt dişlerinizin belirgin olarak önünde duruyor; kayıtlarda bunun bir kısmının çenelerin konumuyla ilgili olduğunu görüyoruz. Büyümeniz tamamlandığı için çene kemiklerinin konumunu apareylerle değiştirmemiz mümkün değil. Bunun yerine iki ana yol var. Birincisi, dişlerin konumunu çenelere uyacak şekilde ayarlamak; bu çoğu zaman bazı dişlerin çekilmesini veya arka dişlerin geriye alınmasını gerektirir. İkincisi, fark büyükse, ortodontiyi çene cerrahisiyle birleştirmek. Bugün sizin için hangi yolun gerçekçi olduğunu, her birinin neyi düzelteceğini ve neyi düzeltemeyeceğini açıkça anlatmak istiyorum. Yüz görünümüyle ilgili beklentinizi de bilmem gerekiyor.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Çekimli planda, üstte genellikle küçük azı dişleri çekilir ve ön dişler geriye alınır. Arka dişlerin istenmeyen şekilde öne kaymasını engellemek için mini vida gibi ek destek gerekebilir; bu küçük bir uygulamadır ve tedavi sonunda çıkarılır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Çeneniz geride ama tellerle hallederiz. | ✓ Teller dişlerin konumunu değiştirir; çene konumu için seçenekleri ayrıca konuşalım. |
| ✗ Ameliyat istemiyorsanız sorun yok, aynısı olur. | ✓ Cerrahisiz plan neyi düzeltir, neyi düzeltemez; bunu açıkça göstereyim. |
| ✗ Yaşınız geçmiş. | ✓ Erişkinde de tedavi mümkündür; yalnızca seçenekler farklıdır. |

# Sınıf II, erişkin, cerrahi sınırda

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Kamuflaj ile cerrahi arasında dürüst karşılaştırma**

**Klinik çerçeve (hekim için):** İskeletsel fark belirgin; kamuflaj ile ortognatik cerrahi arasında sınır vaka. Profil, hava yolu şikâyetleri, hasta beklentisi ve risk algısı konuşulmalı.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Sizin vakanızda çeneler arasındaki fark, yalnızca dişleri hareket ettirerek tam olarak kapatılabilecek sınırın yakınında. Bu nedenle iki yolu yan yana koymak istiyorum. Birinci yol: sadece ortodonti ile dişleri çenelere uyumlu hale getirmek. Bu yol kapanışı iyileştirebilir ama yüz profilindeki farkı büyük ölçüde değiştirmez ve dişleri sınırlarına yakın hareket ettirmeyi gerektirebilir. İkinci yol: ortodontiyi çene cerrahisiyle birleştirmek. Bu yol çene konumunu da ele alır; ancak cerrahinin kendi süreci, iyileşme dönemi ve riskleri vardır. Hangi yolun size uygun olduğuna sizin önceliklerinizle karar vermeliyiz. İsterseniz cerrahi seçenek için çene cerrahisi uzmanının görüşünü de alırız.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Cerrahiyle kombine planda önce dişler ameliyata hazırlanır, sonra cerrahi yapılır, ardından ortodontik bitirme gelir. Ameliyat öncesi dönemde görünüm geçici olarak daha belirgin hale gelebilir; bu planın bir parçasıdır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Ameliyat olmazsanız bir şey yapamam. | ✓ İki seçeneğin neyi sağlayacağını yan yana konuşalım; karar sizin. |
| ✗ Ameliyat çok basit. | ✓ Cerrahinin süreci ve riskleri vardır; uzman görüşüyle birlikte değerlendirelim. |
| ✗ Telle de aynı sonucu alırız. | ✓ Ortodonti kapanışı iyileştirir; profildeki değişim sınırlı olabilir. |

# Sınıf II bölüm 2, çocuk

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Dik kesiciler ve derin kapanış; izlem veya erken düzeltme**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst orta kesiciler içe eğik, yan kesiciler dışa; derin kapanış. Karma veya erken kalıcı dişlenme. Kesici eğiminin düzeltilmesi ve kapanış derinliği takibi.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun üst ön iki dişi içe doğru eğik, yanındaki dişler ise dışa doğru duruyor. Bu, dişlerin üst üste fazla kapanmasıyla birlikte görülen bir durum. Alt dişler bazen üst dişlerin arka yüzüne ya da damağa yakın kapanabilir. Bu tablo kendi kendine düzelmeye çok eğilimli değildir. Bazı çocuklarda ön dişlerin eğimini düzelten basit bir aparey, alt çenenin daha rahat hareket etmesine ve ilerideki tedavinin kolaylaşmasına yardım edebilir. Bazılarında ise kalıcı dişler tamamlanana kadar kontrollü izlem daha uygundur. Bugün çocuğunuz için önerdiğim yolu ve nedenini anlatacağım. Diş eti ve damakta tahriş olup olmadığını da her kontrolde takip edeceğiz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Kullanacağımız aparey ön dişlerin eğimini dışa doğru düzeltmek için tasarlanır. Çocuğunuz ilk günlerde konuşurken biraz zorlanabilir. Aparatın temizliği ve takılma süresi için size yazılı bir talimat vereceğim.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu dişler çok çarpık. | ✓ Ön dişlerin eğimi içe doğru; bunu düzeltmenin yollarını anlatayım. |
| ✗ Hiçbir şey yapmazsak çenesi bozulur. | ✓ Bu durum kendiliğinden düzelmeye eğilimli değil; ne zaman müdahale edeceğimizi birlikte seçelim. |
| ✗ Tek aparatla her şey biter. | ✓ İleride sabit tedavi gerekebileceğini baştan bilmenizi isterim. |

# Sınıf II bölüm 2, erişkin

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Derin kapanışın diş ve diş eti üzerindeki etkisi**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkin; dik üst kesiciler, derin kapanış, olası alt kesici aşınması veya damak tahrişi. Kesici eğiminin düzeltilmesi ve kapanışın açılması planı.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ön dişleriniz içe doğru eğik duruyor ve dişleriniz kapandığında üst dişler alt dişleri olması gerekenden fazla örtüyor. Bunun bazı sonuçlarını muayenede görebiliyoruz; örneğin alt ön dişlerde aşınma ya da damakta hassasiyet. Tedavideki amacımız, ön dişlerin eğimini düzeltmek ve kapanışın derinliğini azaltmak. Böylece dişler arasındaki temasın daha dengeli olmasını hedefliyoruz. Erişkinde bu tür kapanışı açmak zaman alabilir ve sonucun korunması için tedavi sonrası pekiştirmeye özellikle dikkat etmemiz gerekir. Diş eti durumunuz da plana dahil. Tedavinin çene eklemi şikâyetlerini düzeltip düzeltmeyeceğini önceden söyleyemem; bunu açıkça belirtmek isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Kapanışı açmak için ön dişleri bir miktar içeri ve yukarı yönlendirmemiz gerekebilir. Bazı vakalarda arka dişlere küçük kapanış yükseltileri ya da mini vida gibi ek destekler kullanılır. Bunlar geçicidir ve size ayrıca anlatılır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Çene ağrınız bu tedaviyle geçer. | ✓ Ortodontinin eklem şikâyetlerine etkisini önceden söyleyemem; ayrıca değerlendirelim. |
| ✗ Dişleriniz eriyor. | ✓ Alt ön dişlerde aşınma izleri var; bunu durdurmaya yönelik bir plan konuşalım. |
| ✗ Bu kapanış sonra kendini korur. | ✓ Derin kapanış geri dönmeye eğilimlidir; pekiştirme bu yüzden önemli. |

# Dental Sınıf II, iskelet uyumlu

**Kime: Hasta** **Ana mesaj: Sorun çene değil diş konumu; distalizasyon seçeneği**

**Klinik çerçeve (hekim için):** İskelet ilişkisi kabul edilebilir; üst azı dişleri öne kaymış (ör. erken süt dişi kaybı sonrası). Distalizasyon, mini vida destekli mekanik veya çekim seçenekleri.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Çenelerinizin birbirine göre konumu kabul edilebilir sınırlarda. Sorun daha çok üst arka dişlerin zamanla öne doğru kaymış olmasından kaynaklanıyor; bu da ön dişler için yeri daraltıyor ve kapanışı değiştiriyor. Bu durumda tedavide üst arka dişleri kontrollü biçimde geriye almayı düşünebiliriz. Bunun için bazı vakalarda dişlere ek olarak mini vida gibi küçük destekler kullanıyoruz; bu destekler dişlerin istenmeyen yöne hareket etmesini önlüyor. Diğer bir seçenek de bazı dişlerin çekimiyle yer açmak. Her iki yolun da süre, konfor ve sonuç açısından artılarını ve eksilerini konuşalım. Seçtiğimiz planın başarısı, kontrollere düzenli gelmenize de bağlı olacak.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Mini vida, dişlerin arasındaki kemiğe yerleştirilen çok küçük, geçici bir vidadır. Uyuşturma ile kısa sürede uygulanır ve tedavi sonunda çıkarılır. İlk günlerde bölgede hafif hassasiyet olabilir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Vida takacağız, korkacak bir şey yok. | ✓ Mini vidanın ne olduğunu, nasıl takıldığını ve neler hissedebileceğinizi anlatayım. |
| ✗ Dişleri istediğimiz kadar geri alırız. | ✓ Ne kadar geri alabileceğimizi kayıtlarınız belirler. |
| ✗ Çekimli yol eski usul. | ✓ Her iki yol da bazı vakalar için uygundur; sizin için hangisi daha uygun, konuşalım. |

# Artmış overjet, travma riski (çocuk)

Kime: Ebeveyn | Ana mesaj: Öndeki dişler darbelere açık

**Klinik çerçeve (hekim için):** Belirgin overjet, dudak örtüsü yetersiz; kesici travma riski. Erken müdahale (aparey veya sınırlı tedavi) ve koruyucu önlemler gündemde.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun üst ön dişleri belirgin biçimde önde ve dudakları bu dişleri tam olarak örtemiyor. Bu durumda düşme veya çarpma sırasında ön dişlerin zarar görme riski artar. Bu yüzden zamanlamayı yalnızca görünüm açısından değil, dişleri korumak açısından da düşünmemiz gerekiyor. Bazı çocuklarda erken dönemde başlayan bir aparey tedavisi, ön dişlerin konumunu iyileştirip bu riski azaltmaya yardım edebilir. Spor yapıyorsa ağız koruyucu kullanması da önemli. Erken tedavi, ileride ikinci bir tedavi aşamasını her zaman ortadan kaldırmaz; bunu baştan bilmenizi isterim. Ön dişlerden biri darbe alırsa beklemeden diş hekimine başvurmanız gerektiğini de not edelim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Erken aparey tedavisi, ön dişlerin konumunu iyileştirmeyi ve çeneler arasındaki ilişkiyi desteklemeyi amaçlar. Kullanım süresine uyum sonucu doğrudan etkiler; birlikte bir takip tablosu hazırlayabiliriz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Dişleri her an kırılabilir. | ✓ Ön dişler darbelere daha açık; riski azaltmak için seçenekleri konuşalım. |
| ✗ Erken başlarsak ikinci tedavi olmaz. | ✓ Erken tedavi riskleri azaltabilir; ileride ikinci aşama gerekebilir. |
| ✗ Spor yaptırmayın. | ✓ Spora devam edebilir; ağız koruyucu kullanmasını öneriyorum. |

BÖLÜM 4

# Sınıf III Vakaları

Psödo, gerçek iskeletsel ve cerrahi sınırdaki Sınıf III; büyümeyi dürüstçe anlatmak.

*Bu bölümde Vaka 17–21 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 17 | Psödo Sınıf III (çocuk) | Ebeveyn | Kayma ile oluşan ters kapanış; erken düzeltme mantığı |
| 18 | Gerçek iskeletsel Sınıf III (çocuk) | Ebeveyn | Erken ortopedi bir şans; sonuç büyümeye bağlı |
| 19 | Sınıf III, ergen, büyüme takibi | Ergen ve ebeveyn | Büyüme sürerken karar ertelenebilir |
| 20 | Sınıf III, erişkin, kamuflaj | Hasta (erişkin) | Dişsel uyum mümkün; yüz değişimi sınırlı |
| 21 | Sınıf III, cerrahi sınırda | Hasta (erişkin) | Cerrahi seçeneği dürüstçe, baskısız |

# Psödo Sınıf III (çocuk)

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Kayma ile oluşan ters kapanış; erken düzeltme mantığı**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Ön bölgede ters kapanış; sentrik ilişkide başa baş kesici teması elde edilebiliyor. Fonksiyonel kayma; erken düzeltme genellikle gündemde.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun alt ön dişleri, kapanırken üst ön dişlerin önüne geçiyor. Muayenede çenesini yavaşça kapattığında ön dişlerin başa baş gelebildiğini gördük. Bu bize, sorunun büyük bölümünün dişlerin konumundan ve alt çenenin kapanırken öne kaymasından kaynaklandığını düşündürüyor. Bu tür durumlarda erken düzeltme genellikle önerilir; çünkü ters kapanış devam ederse dişler ve çevre dokular bundan etkilenebilir. Tedavi çoğu zaman kısa süreli ve basit apareylerle yapılır. Yine de çocuğunuzun büyümesini kontrollerle takip edeceğiz; çünkü büyüme sırasında tablonun nasıl değiştiğini görmek istiyoruz. Sorularınız varsa şimdi konuşalım.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Kullanacağımız aparey üst ön dişleri biraz öne iterek alt dişlerin arkasına geçmelerini sağlamayı amaçlar. Bazen arka dişlere geçici kapanış yükseltisi eklenir; bu, ön dişlerin rahat hareket etmesi içindir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu basit, sonra hiç sorun çıkmaz. | ✓ Tedavi genellikle kısa sürer; büyümeyi yine de kontrollerle izleyeceğiz. |
| ✗ Çenesi çıkık. | ✓ Alt çene kapanırken öne kayıyor; bunun nedenini anlatayım. |
| ✗ Beklesek de olur. | ✓ Bu tür ters kapanışlarda erken düzeltme genellikle önerilir; nedenini açıklayayım. |

# Gerçek iskeletsel Sınıf III (çocuk)

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Erken ortopedi bir şans; sonuç büyümeye bağlı**

**Klinik çerçeve (hekim için):** İskeletsel Sınıf III bulgular, üst çene gelişimi geride; büyüme döneminde çocuk. RME ve yüz maskesi seçeneği; aile öyküsü ve büyüme yönü sorgulanmalı.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Kayıtlarda çocuğunuzun üst çenesinin alt çeneye göre geride kaldığını görüyoruz. Bu durum dişlerin ötesinde, çene kemiklerinin gelişimiyle ilgili. Büyüme döneminde, üst çene gelişimini desteklemeye yönelik bazı ortopedik apareyler kullanabiliyoruz. Bunlar arasında üst çeneyi genişleten bir aparey ve gece ağırlıklı kullanılan bir yüz maskesi olabilir. Açıkça söylemem gereken bir şey var: bu tür vakalarda büyüme ileriki yıllarda da devam eder ve sonucun ne kadar kalıcı olacağı büyümenin yönüne bağlıdır. Bu yüzden düzenli takip yapacağız ve ileride ek tedavi, hatta büyüme bittiğinde çene cerrahisi gerekebilir. Ailede benzer bir durum olup olmadığını da öğrenmek isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Genişletme apareyi üst damağa sabitlenir; size gösterilen şekilde belirli aralıklarla çevrilir. Yüz maskesi daha çok evde ve gece kullanılır. Düzenli kullanım, sonucu doğrudan etkiler. Hangi saatlerde takılacağını birlikte planlayalım.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Maskeyle çenesi tamamen düzelir. | ✓ Üst çene gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz; büyümeyi yıllarca izleyeceğiz. |
| ✗ Erken başlarsak ameliyat kesin gerekmez. | ✓ Erken tedavi bir fırsat; ileride cerrahi gerekebileceğini de bilmelisiniz. |
| ✗ Maske takmazsa işe yaramaz, karar sizin. | ✓ Çocuğunuzun maskeye alışması için birlikte bir plan yapalım. |

# Sınıf III, ergen, büyüme takibi

**Kime: Ergen ve ebeveyn** **Ana mesaj: Büyüme sürerken karar ertelenebilir**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Ergen; hafif-orta iskeletsel Sınıf III eğilim, büyüme devam ediyor. Erken kamuflaj riskli olabilir; izlem ve büyüme sonu değerlendirmesi seçenek.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Kayıtlarda alt çenenin üst çeneye göre biraz önde olduğunu görüyoruz. Büyümeniz devam ettiği için bu ilişkinin önümüzdeki yıllarda nasıl değişeceğini tam olarak bilemiyoruz; alt çenenin büyümesi bazen ergenlik sonuna kadar sürebilir. Bu nedenle şu an kalıcı bir karar vermek yerine, dişleri düzenli tutacak sınırlı bir tedavi veya kontrollü bir izlem önerebilirim. Büyüme yavaşladığında yeniden kayıt alıp, yalnızca ortodontiyle mi ilerleyeceğimizi yoksa çene cerrahisinin de seçenek olup olmadığını değerlendireceğiz. Bu bekleme süresi boşa geçmiş zaman değildir; doğru kararı verebilmek için gerekli bir dönemdir. Hem sizin hem ailenizin görüşünü önemsiyorum.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Şu aşamada uyguladığımız tedavi, dişlerin diziliş ve kapanışını idare etmeye yöneliktir. Asıl karar büyüme yavaşladığında yeniden alınacak kayıtlarla verilecek. Bu planı yazılı olarak sizinle paylaşacağım.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Büyüyünce ameliyat olursunuz. | ✓ Büyüme yavaşladığında seçenekleri yeniden değerlendireceğiz. |
| ✗ Şimdi tel takarsak sorun kalmaz. | ✓ Büyüme devam ederken bazı sonuçlar değişebilir; bu yüzden izleyeceğiz. |
| ✗ Bekleyerek zaman kaybediyoruz. | ✓ Bu izlem dönemi doğru karar için gerekli bir aşamadır. |

# Sınıf III, erişkin, kamuflaj

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Dişsel uyum mümkün; yüz değişimi sınırlı**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkin; hafif-orta iskeletsel Sınıf III, kamuflaja uygun sınırlar. Alt kesici geri alma, üst kesici öne alma; dişeti ve kemik sınırları dikkate alınmalı.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Alt çeneniz üst çenenize göre biraz önde. Büyümeniz tamamlandığı için bu ilişkiyi apareylerle değiştirmemiz mümkün değil; ancak farkın derecesi, dişlerin konumunu ayarlayarak kapanışı düzeltmeye uygun görünüyor. Bu planda üst ön dişleri bir miktar öne, alt ön dişleri bir miktar geriye yönlendirmeyi hedefliyoruz. Bunun bir sınırı var: dişler, kemik ve diş eti desteğinin izin verdiği kadar hareket edebilir. Bu nedenle yüz profilinizde büyük bir değişiklik beklemenizi doğru bulmam. Profil önceliğiniz, çene cerrahisiyle kombine tedavi seçeneğini de ayrıca konuşabiliriz. Hangisinin sizin beklentinize uyduğunu birlikte belirleyelim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bu planda bazen alt çenede yer açmak için diş çekimi veya mini vida gibi ek destekler gerekebilir. Ayrıca çeneler arasına takılan elastikler kullanılır. Hepsinin nedenini ve nasıl kullanılacağını adım adım göstereceğim.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Çenenizi geri alacağız. | ✓ Dişlerin konumunu çenelere uydurmayı hedefliyoruz; çene konumu değişmez. |
| ✗ Profiliniz de düzelir. | ✓ Profildeki değişim sınırlı olabilir; beklentimizi netleştirelim. |
| ✗ Ameliyat gereksiz bir iş. | ✓ Cerrahi bazı hastalar için doğru seçenektir; ihtiyacınız olursa bilgi veririm. |

# Sınıf III, cerrahi sınırda

Kime: Hasta (erişkin) | Ana mesaj: Cerrahi seçeneği dürüstçe, baskısız

**Klinik çerçeve (hekim için):** Belirgin iskeletsel Sınıf III, olası asimetri; kamuflajın sınırlarında veya dışında. Ortognatik cerrahi ile kombine tedavi değerlendirilmeli; çene cerrahisi konsültasyonu.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Kayıtlarınızda alt ve üst çene arasındaki farkın oldukça belirgin olduğunu görüyoruz. Bu kadar farkı yalnızca dişleri hareket ettirerek kapatmaya çalışmak, dişleri kemik desteğinin sınırlarına zorlamak anlamına gelebilir ve yüz görünümünüzü pek değiştirmez. Bu nedenle size ortodontiyi çene cerrahisiyle birleştiren bir planı da sunmak istiyorum. Bu bir zorunluluk değil, bir seçenek. Cerrahinin bir hazırlık dönemi, hastanede geçen bir süreç ve iyileşme dönemi vardır; riskleri ve faydaları çene cerrahisi uzmanı tarafından ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Cerrahi istemezseniz, sınırlı bir ortodontik planın neler sağlayabileceğini de açıkça konuşuruz. Acele etmeden düşünmeniz önemli.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Kombine planda ortodonti cerrahiden önce başlar ve dişleri çene ameliyatına hazırlar. Bu dönemde kapanış geçici olarak daha belirgin görünebilir. Ameliyat sonrası kısa bir ortodontik bitirme aşaması gelir. Uzman görüşmesine birlikte hazırlanalım.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Tek çözüm ameliyat. | ✓ Cerrahi kombine plan bir seçenek; cerrahisiz planın sınırlarını da anlatacağım. |
| ✗ Ameliyat çok kolay, korkmayın. | ✓ Cerrahinin süreci ve riskleri uzman tarafından ayrıntılı anlatılmalı. |
| ✗ Hemen karar vermeniz gerekiyor. | ✓ Acele etmeden, bilgi alarak karar vermeniz önemli. |

BÖLÜM 5

# Vertikal ve Transversal Problemler

Açık, derin, çapraz ve makaslama kapanış.

*Bu bölümde Vaka 22–28 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 22 | Ön açık kapanış, çocuk (alışkanlık) | Ebeveyn ve çocuk | Önce alışkanlık, sonra dişler |
| 23 | Ön açık kapanış, erişkin | Hasta (erişkin) | Nedeni çok yönlü; nüks eğilimi açıkça |
| 24 | Derin kapanış | Hasta veya ebeveyn | Fazla örtme diş ve dişetini yorar |
| 25 | Tek taraflı arka çapraz kapanış (çocuk) | Ebeveyn | Dar üst çene ve yana kayma; erken düzeltme |
| 26 | Dar üst çene, erişkin | Hasta (erişkin) | Sütür kapalıysa seçenekler farklı |
| 27 | Tek dişte ön çapraz kapanış | Hasta veya ebeveyn | Kilitlenen diş; diş ve dişeti için erken çözüm |
| 28 | Makaslama kapanış | Hasta | Dış tarafa kaçan arka dişler; ayrıntılı plan |

# Ön açık kapanış, çocuk (alışkanlık)

Kime: Ebeveyn ve çocuk | Ana mesaj: Önce alışkanlık, sonra dişler

**Klinik çerçeve (hekim için):** Karma dişlenmede ön açık kapanış; parmak emme, emzik veya dil itimi öyküsü. Alışkanlığın bırakılması ve gerekirse alışkanlık kırıcı aparey.

### HASTAYA / EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuz dişlerini kapattığında ön dişler birbirine değmiyor; arada bir aralık kalıyor. Bu durum bu yaşta çoğu zaman parmak emme, dudak veya dil alışkanlıklarıyla ilişkilidir. İlk ve en önemli adım, alışkanlığın azalmasını sağlamak. Alışkanlık devam ettiği sürece yaptığımız tedavinin etkisi sınırlı kalabilir. Bunu çocuğunuzu suçlamadan, onu ödüllendirerek ve destekleyerek yapmak çok daha işe yarar. Gerekirse alışkanlığı hatırlatan basit bir aparey kullanabiliriz. Bazı çocuklarda alışkanlık bittikten sonra açıklık kendiliğinden azalabilir; bazılarında ise ek tedavi gerekir. Konuşma veya yutkunma ile ilgili bir sorun fark ederseniz, bunu da birlikte değerlendirebiliriz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Alışkanlık kırıcı aparey, dilin veya parmağın ön dişlere baskı yapmasını zorlaştıran küçük bir aparattır. Ceza değildir; çocuğunuza hatırlatıcı gibi anlatılmalıdır. İlk günlerde konuşma ve yemek yemede alışma süresi olabilir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Parmağını emmeyi bırakmazsa dişleri bozulur. | ✓ Alışkanlık azaldıkça tedavi daha iyi çalışır; birlikte destekleyelim. |
| ✗ Bu aparat parmağını emmesin diye ceza. | ✓ Bu aparat bir hatırlatıcıdır. |
| ✗ Kendiliğinden düzelir. | ✓ Bazı çocuklarda azalabilir; kontrollerle takip edeceğiz. |

# Ön açık kapanış, erişkin

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Nedeni çok yönlü; nüks eğilimi açıkça**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkinde ön açık kapanış; iskeletsel dikey yön, dil konumu, solunum öyküsü olası katkılar. Mekanik seçenekler: mini vida destekli intrüzyon, ekstrüzyon, cerrahi.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Dişlerinizi kapattığınızda ön dişleriniz birbirine değmiyor. Erişkinde bu durumun genellikle birden fazla nedeni olur: çenelerin dikey yöndeki yapısı, dilin dinlenme konumu ve geçmişteki alışkanlıklar gibi. Tedavide amacımız ön dişlerin temasını sağlamak ve ısırma fonksiyonunu iyileştirmek. Bunun için arka dişleri hafifçe gömmek, ön dişleri hafifçe uzatmak veya fark büyükse çene cerrahisiyle birleştirmek gibi seçenekler var. Bu tür kapanışların tedaviden sonra kısmen geri dönme eğilimi olduğunu açıkça söylemek isterim. Bu yüzden pekiştirme ve gerekirse dil alışkanlığına yönelik destek planın parçası olacak. Hangi seçeneğin sizin için gerçekçi olduğunu birlikte konuşalım.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Arka dişleri bir miktar gömmek için mini vidalardan destek alabiliriz. Bunlar diş aralarına uygulanan küçük, geçici vidalardır ve tedavi sonunda çıkarılır. Hangi bölgeye ve neden uygulanacağını kayıtlarda göstereceğim.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu kapanış bir kez düzelince kalıcıdır. | ✓ Açık kapanış geri dönme eğilimi gösterebilir; pekiştirme bu yüzden önemli. |
| ✗ Diliniz yüzünden oldu. | ✓ Dilin konumu katkı yapabilir; diğer nedenleri de birlikte değerlendirdik. |
| ✗ Ameliyat gerekmez, merak etmeyin. | ✓ Farkın büyüklüğüne göre cerrahi seçeneği de konuşmamız gerekebilir. |

# Derin kapanış

**Kime: Hasta veya ebeveyn** **Ana mesaj: Fazla örtme diş ve dişetini yorar**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Belirgin overbite; alt kesiciler damak mukozasına veya üst kesici palatinaline temas. Spee eğrisi derin olabilir. Kesici intrüzyonu, posterior ekstrüzyon seçenekleri.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Dişleriniz kapandığında üst ön dişler alt ön dişleri olması gerekenden fazla örtüyor. Bazen alt dişler damağa ya da üst dişlerin arka yüzüne değecek kadar derin kapanıyor. Bu durum zamanla diş aşınmasına, damakta hassasiyete veya ön dişlerin konumunun değişmesine yol açabilir. Tedavide amacımız kapanışın derinliğini azaltmak ve ön dişler arasındaki teması dengelemek. Bunun için ön dişleri bir miktar içeri almak, arka dişlerin kapanışını ayarlamak ya da ikisini birleştirmek gibi yöntemler kullanılır. Derin kapanış tedavi sonrası geri dönmeye eğilimli olabilir; bu nedenle pekiştirme aşamasını baştan planlıyoruz. Sizi rahatsız eden belirtiler varsa önce onları duymak isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bazı vakalarda arka dişlere ya da üst ön dişlerin arka yüzüne küçük kapanış yükseltileri yapıştırılır. Bunlar dişlerin geçici olarak daha az kapanmasını sağlar. İlk günlerde çiğnerken farklı hissedebilirsiniz; bu genellikle alışılan bir durumdur.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Alt dişleriniz damağınızı yiyor. | ✓ Alt dişler damağa yakın kapanıyor; bunu azaltmak için plan konuşalım. |
| ✗ Derin kapanış kendiliğinden düzelmez, hemen başlamalıyız. | ✓ Bu kapanışın etkilerini ve zamanlamayı birlikte değerlendirelim. |
| ✗ Pekiştirme sadece birkaç ay. | ✓ Derin kapanışta pekiştirme süresini uzun planlarız. |

# Tek taraflı arka çapraz kapanış (çocuk)

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Dar üst çene ve yana kayma; erken düzeltme**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Tek taraflı posterior çapraz kapanış, çoğu zaman dar üst çene ve kapanırken mandibular kayma ile. Büyüme döneminde RME seçeneği.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuz dişlerini kapatırken bir taraftaki arka dişler ters kapanıyor ve alt çene o tarafa doğru kayıyor. Çoğu zaman bunun nedeni üst çenenin biraz dar olmasıdır. Büyüme döneminde üst çeneyi genişletmek için kullanılan apareyler bu yaşta genellikle iyi sonuç verir; çünkü üst çenenin ortasındaki büyüme hattı henüz kaynaşmamıştır. Bu kaymanın uzun süre devam etmesi, çene gelişiminin dengesini etkileyebilir; bu yüzden erken düzeltmeyi öneriyorum. Tedavinin genişletme aşaması genellikle kısa sürer; ardından elde edilen genişliğin korunması için aparey bir süre ağızda kalır. Ağız solunumu veya horlama fark ettiyseniz bunu da not etmek isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Genişletme apareyi üst damağa sabitlenir ve size gösterilen şekilde çevrilir. İlk çevirmelerde burun ve damak bölgesinde baskı hissi olabilir. Ön dişler arasında geçici bir aralık açılabilir; bu beklenen bir durumdur ve sonradan kapanır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Çenesi yamuk büyüyor. | ✓ Alt çene kapanırken bir tarafa kayıyor; bunu düzeltmenin yollarını anlatayım. |
| ✗ Hiç acımaz. | ✓ İlk günlerde baskı hissi olabilir; bu genellikle kısa sürer. |
| ✗ Arada açılan boşluk sorun. | ✓ Ön dişlerde geçici bir aralık açılması beklenen bir durumdur. |

# Dar üst çene, erişkin

Kime: Hasta (erişkin) | Ana mesaj: Sütür kapalıysa seçenekler farklı

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkinde bilateral posterior çapraz kapanış, dar üst çene. Dental genişletme sınırları, mini vida destekli genişletme veya cerrahi destekli genişletme değerlendirilmeli.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst çeneniz alt çenenize göre dar ve bu yüzden arka dişleriniz iki tarafta da ters kapanıyor. Çocuklarda üst çenenin orta hattı henüz kaynaşmadığı için genişletme daha kolaydır. Erişkinde bu hat büyük ölçüde kaynaştığından seçenekler değişir. Hafif darlıklarda dişleri kontrollü biçimde dışa eğerek sınırlı bir genişlik kazanabiliriz; ancak bunun diş eti ve kemik desteği açısından bir sınırı vardır. Darlık belirginse, kemik destekli genişletme veya cerrahi destekli genişletme gündeme gelebilir. Bugün size, sizin durumunuzda hangi yolun gerçekçi olduğunu ve her birinin neleri gerektirdiğini anlatacağım. Diş eti sağlığınızı tüm süreç boyunca yakından izleyeceğiz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Kemik destekli genişletmede aparey dişlerin yanında damağa yerleştirilen küçük vidalardan destek alır. Cerrahi destekli genişletmede ise genişletmeden önce küçük bir cerrahi işlem yapılır. Bu seçenekleri ilgili uzmanla birlikte değerlendiririz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Tellerle genişletiriz, olur. | ✓ Erişkinde genişletmenin sınırları var; seçenekleri açıkça konuşalım. |
| ✗ Çocukken getirseydiniz. | ✓ Bugünkü durumunuz için en uygun yolu birlikte belirleyelim. |
| ✗ Diş etine bir şey olmaz. | ✓ Diş eti sağlığınızı tedavi boyunca yakından izleyeceğiz. |

# Tek dişte ön çapraz kapanış

**Kime: Hasta veya ebeveyn** **Ana mesaj: Kilitlenen diş; diş ve dişeti için erken çözüm**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Tek bir üst kesici altın arkasında kapanıyor; olası dişeti çekilmesi veya mine aşınması. İskelet ilişkisi genellikle normal. Basit mekanikle düzeltme.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst ön dişlerinizden biri, kapanırken alt dişin arkasında kalıyor. Diğer dişleriniz normal ilişkide olduğu için bu sorunun çene yapısından değil, o dişin konumundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu durum devam ederse alt dişte diş eti çekilmesine veya iki dişte de aşınmaya yol açabilir. Bu nedenle düzeltmeyi bekletmemenizi öneriyorum. Bu tür tek diş sorunları çoğu zaman sınırlı bir tedaviyle düzeltilebilir; ancak dişi öne almak için yeterli yer olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yer yetersizse önce yer açmamız gerekir. Tedavi sonrası dişin yeniden içeri kaçmaması için pekiştirme planlayacağız.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Dişi öne almak için küçük bir aparey ya da sınırlı bir sabit tedavi kullanabiliriz. Diş takılmadan rahat hareket etsin diye arka dişlere geçici kapanış yükseltisi eklenebilir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bir dişiniz ters, önemli değil. | ✓ Bu diş zamanla diş eti ve mine üzerinde etki yapabilir; erken düzeltmeyi öneriyorum. |
| ✗ İki haftada düzeltiriz. | ✓ Süre yer durumuna bağlı; kontrollerde netleştiririz. |
| ✗ Pekiştirmeye gerek yok. | ✓ Diş yeniden içeri kaçmasın diye pekiştirme planlıyoruz. |

# Makaslama kapanış

Kime: Hasta | Ana mesaj: Dış tarafa kaçan arka dişler; ayrıntılı plan

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst arka diş(ler) alt dişlerin bukkalinde, temas yok; tek diş veya segment. Diş eğimi, ekstrüzyon ve ankraj ihtiyacı değerlendirilmeli; mini vida destekli mekanik seçenek.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Arka dişlerinizden bazıları kapanırken karşı dişle üst üste gelmek yerine onun dış yanından geçiyor. Bu durumda o dişler çiğnemeye tam katılamaz ve zamanla olması gerekenden fazla uzayabilir. Tedavide amacımız bu dişleri karşı dişleriyle doğru ilişkiye getirmek. Bunun için dişi içe doğru eğmek, gerekirse biraz gömmek ve karşı dişi de uygun konuma getirmek gerekebilir. Bazı vakalarda bu hareketleri istenmeyen yan etkiler olmadan yapmak için mini vida gibi geçici destekler ya da çapraz elastikler kullanıyoruz. Tek dişle sınırlı bir sorunsa tedavi daha kısa olabilir; birden fazla diş etkileniyorsa plan daha kapsamlı olur. Bunu kayıtlar üzerinde size göstereceğim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Çapraz elastikler, üst ve alt dişlere yapıştırılan küçük düğmeler arasına takılan lastiklerdir. Her gün sizin tarafınızdan değiştirilir. İlk günlerde çiğnerken hassasiyet olabilir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu dişler tamamen yanlış. | ✓ Bu dişler karşı dişleriyle tam temas etmiyor; düzeltme yollarını anlatayım. |
| ✗ Elastikleri arada bir takmanız yeter. | ✓ Elastiklerin düzenli kullanımı hareketin gerçekleşmesi için gereklidir. |
| ✗ Çok çabuk düzelir. | ✓ Süre etkilenen diş sayısına bağlı; kayıtlarla birlikte bakalım. |

BÖLÜM 6

# Diş Sayısı ve Diş Konumu

Gömülü, eksik, fazla ve ankiloze dişler; yer kaybı.

*Bu bölümde Vaka 29–34 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 29 | Gömülü üst kanin | Hasta veya ebeveyn | Cerrahi açma ve dişin yerine getirilmesi |
| 30 | Doğuştan eksik üst yan kesici | Hasta veya ebeveyn | Yer açmak mı kapatmak mı |
| 31 | Erken süt dişi kaybı, yer tutucu | Ebeveyn | Kaybolan yer kolay geri gelmez |
| 32 | Erişkinde eksik diş, implant öncesi ortodonti | Hasta (erişkin) | Yer hazırlamak multidisipliner bir iş |
| 33 | Fazla diş (meziodens) veya sürmemiş kesici | Ebeveyn | Engel kaldırılmadan diş çıkmaz |
| 34 | Ankiloz şüphesi olan süt dişi | Ebeveyn | Diş kemiğe kaynaşmış olabilir; izlem ve zamanlama |

# Gömülü üst kanin

**Kime: Hasta veya ebeveyn** **Ana mesaj: Cerrahi açma ve dişin yerine getirilmesi**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst kanin gömülü veya sürme yolu sapmış; konumu üç boyutlu görüntüleme ile belirlenmiş olabilir. Seçenekler: süt kaninin çekimi ve izlem, cerrahi açma + ortodontik traksiyon, nadir durumlarda çekim.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Üst köpek dişiniz kendi başına sürememiş ve kemik içinde kalmış. Kayıtlarda dişin nerede durduğunu ve komşu dişlerin köklerine ne kadar yakın olduğunu inceledik. Bu dişi yerine getirmek çoğu zaman mümkün olur, ancak bunun için ağız cerrahının dişin üzerini açması ve dişe küçük bir düğme yapıştırması gerekir. Ardından tellerle bu dişi yavaşça ve kontrollü biçimde yerine çekeriz. Bu süreç diğer dişlerin düzenlenmesinden daha uzun sürebilir. Dişin konumuna göre farklı seçenekler de olabilir; bazen yalnızca süt dişini çekip bir süre izlemek yeterli olabilir. Hangi yolun uygun olduğunu kayıtlar üzerinde göstererek anlatacağım.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Cerrahi açma, ağız cerrahı tarafından uyuşturma altında yapılan bir işlemdir. Sonrasında birkaç gün hassasiyet olabilir. Dişe yapıştırılan küçük bir düğme ile dişi yavaşça yerine yönlendiririz. Diş yerine gelene kadar düzenli kontrol önemlidir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu dişi kesin yerine getiririz. | ✓ Çoğu vakada mümkündür; dişinizin konumuna göre seçenekleri anlatayım. |
| ✗ Komşu dişin kökü erimiş. | ✓ Kayıtlarda komşu dişle ilişkiyi değerlendirdik; ne gördüğümüzü birlikte inceleyelim. |
| ✗ Küçük bir kesik atılır, önemsiz. | ✓ Cerrahi açma bir işlemdir; ağız cerrahı size ayrıntılı bilgi verecek. |

# Doğuştan eksik üst yan kesici

Kime: Hasta veya ebeveyn | Ana mesaj: Yer açmak mı kapatmak mı

**Klinik çerçeve (hekim için):** Bir veya iki üst lateral kesicinin agenezisi. Seçenekler: boşluğu kapatıp kanini lateral şekline getirmek veya yeri koruyup ileride protetik/implant çözüm.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Kayıtlarda bir yan ön dişinizin hiç oluşmadığını görüyoruz. Bu durumda iki ana yol var. Birincisi, boşluğu kapatmak: köpek dişini bu boşluğa doğru ilerletip şeklini dolgu veya küçük düzeltmelerle yan dişe benzetmek. İkincisi, boşluğu doğru genişlikte korumak ve ileride bu alana bir diş yapılmasını planlamak. İkinci yolda, kalıcı çözüm genellikle büyüme tamamlandıktan sonra yapılır; o zamana kadar geçici bir çözüm kullanılır. Hangi yolun uygun olduğu kapanışa, köpek dişinin şekline ve rengine, gülüş hattına ve sizin tercihinize bağlıdır. Her iki seçenekte de diş hekiminizle ya da protez uzmanıyla birlikte çalışacağız.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Yeri koruma seçeneğinde boşluk, ileride yapılacak diş için doğru genişlikte tutulur. Bu dönemde estetik için geçici bir diş kullanılabilir. Kalıcı çözümün zamanı büyüme tamamlandığında belirlenir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ İmplant yaparız, kolay. | ✓ İleride bu alana diş yapılabilir; zamanlamasını ve gereklerini birlikte planlayalım. |
| ✗ Kapatırsak kimse anlamaz. | ✓ Köpek dişinin şekli ve rengi sonucu etkiler; artı ve eksileri konuşalım. |
| ✗ Hangi yol olursa aynı. | ✓ İki yolun bakım, süre ve estetik açısından farkları var. |

# Erken süt dişi kaybı, yer tutucu

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Kaybolan yer kolay geri gelmez**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Süt azı dişinin erken kaybı (çürük veya çekim); kalıcı dişin sürmesine zaman var. Yer tutucu ile yer korunması gündemde.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun bir süt azı dişi, alttaki kalıcı diş çıkmadan önce kaybedilmiş. Bu dişin görevi, kalıcı diş gelene kadar yeri korumaktı. Boşluk korunmazsa yan dişler bu alana doğru kayabilir ve kalıcı dişin çıkacağı yer daralabilir. Bu durum ileride çapraşıklığa ya da dişin gömülü kalmasına yol açabilir. Bunu önlemek için yer tutucu denilen basit bir aparey öneriyorum. Bu aparey, kalıcı diş çıkana kadar boşluğu korur ve kontrollerde takip edilir. Kalıcı diş sürmeye başladığında apareyi çıkarırız. Bu dönemde diğer süt dişlerini çürükten korumak da en az bu aparey kadar önemlidir.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Yer tutucu, komşu dişe takılan ya da damağa dayanan küçük bir aparattır. Çiğnemeye ve konuşmaya çoğu çocuk kısa sürede alışır. Yapışkan ve sert yiyeceklerden kaçınmak, apareyin yerinden oynamasını önler.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu yeri kaybederseniz dişi hiç çıkmaz. | ✓ Yer korunmazsa kalıcı dişin çıkması zorlaşabilir; bu yüzden yer tutucu öneriyorum. |
| ✗ Süt dişi zaten düşecekti. | ✓ Süt dişi kalıcı diş için yer tutuyordu; şimdi bu görevi aparey üstlenecek. |
| ✗ Yer tutucu ömür boyu kalır. | ✓ Kalıcı diş sürmeye başladığında çıkarılır. |

# Erişkinde eksik diş, implant öncesi ortodonti

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Yer hazırlamak multidisipliner bir iş**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkin; çekilmiş dişin yerine komşu dişler eğilmiş, karşı diş uzamış. Protetik/implant öncesi dişlerin dikleştirilmesi ve yer düzenlemesi.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Yıllar önce çekilen bir dişin boşluğuna doğru komşu dişleriniz eğilmiş ve karşı çenedeki diş biraz uzamış. Bu yüzden bu alana doğru bir diş yapılması zorlaşıyor. Ortodonti burada, protez veya implant hekiminizin çalışabileceği uygun bir alan hazırlamak için kullanılabilir. Eğilmiş dişleri dikleştirip, boşluğu doğru genişliğe getirmeyi ve karşı dişin konumunu iyileştirmeyi hedefliyoruz. Bu tedavi çoğu zaman tüm ağzı kapsamayan, sınırlı bir tedavidir. Planı, sizi tedavi edecek diğer hekimle birlikte yapacağız; böylece ortodontinin bitişi ile protez aşaması arasında boşluk kalmaz. Diş eti sağlığınızı da süreç boyunca takip edeceğiz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bu tedavide yalnızca ilgili bölgeye braket veya küçük aparatlar uygulanabilir. Bazen dişleri istediğimiz yöne hareket ettirmek için mini vidadan destek alırız. Bitişte protez hekiminiz için alanın hazır olduğunu birlikte kontrol ederiz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu dişi çektirdiğiniz için böyle oldu. | ✓ Zamanla komşu dişler boşluğa eğilmiş; bunu düzeltmek mümkün. |
| ✗ Ortodonti bitince implant kesin olur. | ✓ Uygun alanı hazırlamayı hedefliyoruz; implant kararını ilgili hekim verir. |
| ✗ Tüm dişlere tel gerekir. | ✓ Çoğu zaman sınırlı bir tedavi yeterli olabilir; planı birlikte yapalım. |

# Fazla diş (meziodens) veya sürmemiş kesici

Kime: Ebeveyn | Ana mesaj: Engel kaldırılmadan diş çıkmaz

**Klinik çerçeve (hekim için):** Üst orta bölgede süpernümerer diş; kalıcı kesicinin sürmesini engelliyor veya diastemaya yol açıyor. Cerrahi çekim, izlem, gerekirse yer açma ve traksiyon.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Kayıtlarda çocuğunuzun üst ön bölgesinde fazladan bir diş olduğunu görüyoruz. Bu diş, kalıcı ön dişin çıkmasını engelliyor ya da ön dişlerin arasının açılmasına neden oluyor olabilir. Fazla dişin çıkarılması genellikle ağız cerrahı tarafından yapılır. Bu dişin alınmasından sonra kalıcı dişin kendiliğinden sürüp sürmeyeceğini bir süre takip ederiz. Bazı durumlarda diş kendi başına çıkar; bazılarında ise yer açmak ve dişi ortodontik olarak yönlendirmek gerekir. Bu sürecin aşamalarını ve kontrol zamanlarını size yazılı olarak vereceğim. Çocuğunuzun bu süreçte endişelenmemesi için ona da yaşına uygun şekilde açıklama yapmak isterim.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Fazla dişin çıkarılması uyuşturma altında yapılan kısa bir cerrahi işlemdir. İşlemden sonra birkaç hafta veya ay boyunca kalıcı dişin sürmesini izleriz. Gerekirse sonraki aşamada dişi yerine yönlendirmek için sınırlı bir tedavi yaparız.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu diş bir anormallik. | ✓ Fazla diş görülebilen bir durumdur; ne yapacağımızı adım adım anlatayım. |
| ✗ Çıkarınca diş hemen gelir. | ✓ Çıkarıldıktan sonra kalıcı dişin sürmesini bir süre izleyeceğiz. |
| ✗ Ameliyat çok ufak, hiç sorun olmaz. | ✓ Kısa bir işlemdir; ağız cerrahı size ayrıntılı bilgi verecek. |

# Ankiloz şüphesi olan süt dişi

**Kime: Ebeveyn** **Ana mesaj: Diş kemiğe kaynaşmış olabilir; izlem ve zamanlama**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Süt azı dişi komşularına göre aşağıda kalmış (infraokluzyon), perküsyonda farklı ses olabilir. Altında kalıcı dişin varlığı, ilerleme hızı ve komşu dişlerin eğimi izlenmeli.

### EBEVEYNE NE SÖYLENİR

«Çocuğunuzun bir süt azı dişi, yanındaki dişlere göre daha aşağıda kalmış görünüyor. Bu durum genellikle dişin köklerinin çevredeki kemiğe kaynaşmasıyla ilişkilidir. Böyle bir diş, çene büyürken diğer dişlerle birlikte yükselemez ve zamanla daha da aşağıda kalabilir. Altında kalıcı diş varsa ve ilerleme yavaşsa bir süre izlemek yeterli olabilir. Ancak komşu dişler bu dişin üzerine eğilmeye başlarsa ya da fark artarsa, dişin çekilmesi ve yerin korunması gündeme gelebilir. Altında kalıcı diş yoksa plan farklıdır; bunu ayrıca konuşmamız gerekir. Bu dişi düzenli kontrollerde ölçerek takip edeceğiz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Çekim gerekirse ardından boşluğu korumak için yer tutucu kullanılabilir. Altta kalıcı diş yoksa, bu süt dişini bir süre korumak veya boşluğu planlı biçimde yönetmek gibi seçenekleri birlikte değerlendiririz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Bu diş ölü. | ✓ Dişin kökü kemiğe kaynaşmış olabilir; bunu kontrollerde takip edeceğiz. |
| ✗ Hemen çekmeliyiz. | ✓ Altındaki kalıcı dişe ve ilerleme hızına göre karar vereceğiz. |
| ✗ Kendiliğinden düzelir. | ✓ Bu diş genellikle kendiliğinden yükselmez; düzenli izlem gerekir. |

BÖLÜM 7

# Erişkin ve Özel Durumlar

Periodontal hasta, şeffaf plak isteği, nüks, sınırlı tedavi ve TME yakınması.

*Bu bölümde Vaka 35–40 yer alıyor. Tablodan vakayı bulun, ilgili sayfayı açın.*

| NO | VAKA TİPİ | KİME | ANA MESAJ |
|---|---|---|---|
| 35 | Erişkin periodontal hasta | Hasta (erişkin) | Önce diş eti sağlığı; sonra hafif kuvvet |
| 36 | Şeffaf plak isteyen hasta (uygun vaka) | Hasta | İstek uygun; uyum şartı açıkça |
| 37 | Şeffaf plak isteyen hasta (sınırlı vaka) | Hasta | İsteği küçümsemeden dürüst sınır |
| 38 | Nüks: dişler yeniden çapraştı | Hasta (erişkin) | Suçlamadan, nedeni ve çözümü konuşmak |
| 39 | Sadece ön dişleri isteyen erişkin | Hasta (erişkin) | Sınırlı tedavinin sınırları yazılı olsun |
| 40 | Çene eklemi (TME) yakınması olan hasta | Hasta | Ortodonti TME tedavisi değildir |

# Erişkin periodontal hasta

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Önce diş eti sağlığı; sonra hafif kuvvet**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkin; kemik kaybı, ön dişlerde yelpazelenme veya migrasyon. Periodontal tedavi ve stabilizasyon önce; hafif kuvvetler, uzun süreli sabit pekiştirme.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Diş eti ve kemik desteğinizde geçmişte bir kayıp olmuş ve ön dişlerinizin zamanla yer değiştirmesi büyük ölçüde bununla ilişkili. Ortodontik tedavi bu dişleri yeniden sıraya koymaya ve temizlenmeyi kolaylaştırmaya yardım edebilir. Ancak buradaki en önemli kural şu: diş eti hastalığı kontrol altında olmadan dişleri hareket ettirmeyiz. Önce periodontoloğunuzla birlikte diş eti tedavisini tamamlayacağız ve düzenli bakım programınızı oluşturacağız. Tedavi sırasında daha hafif kuvvetler kullanıp diş eti durumunuzu sık aralıklarla kontrol edeceğiz. Kaybedilmiş kemiği ortodontiyle geri kazandırmayı vaat edemem. Dişlerin yeni konumunu korumak için genellikle uzun süreli sabit pekiştirme gerekir.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bu tedavide braketler veya şeffaf plaklar kullanılabilir; seçim diş eti durumunuza ve temizlik kolaylığına göre yapılır. Tedavi süresince düzenli diş eti bakım randevularınız devam eder.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Tellerle diş etiniz de düzelir. | ✓ Ortodonti temizliği kolaylaştırabilir; diş eti tedavisi ayrıca sürer. |
| ✗ Diş etinizi ihmal etmişsiniz. | ✓ Diş eti durumunuzu birlikte kontrol altında tutacağız. |
| ✗ Kemik geri gelir. | ✓ Kaybedilen kemiği geri kazandırmayı vaat edemem; mevcut desteği korumayı hedefliyoruz. |

# Şeffaf plak isteyen hasta (uygun vaka)

Kime: Hasta | Ana mesaj: İstek uygun; uyum şartı açıkça

**Klinik çerçeve (hekim için):** Hasta görünmez bir yöntem istiyor; vaka şeffaf plak ile planlanabilir. Günlük kullanım süresi, ataşmanlar, IPR ve olası ara düzeltmeler anlatılmalı.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Sizin vakanız şeffaf plak tedavisiyle planlanmaya uygun görünüyor. Bu yöntemde dişlerinize her biri biraz farklı olan şeffaf plaklar takılır ve dişler adım adım hareket eder. En önemli nokta şu: şeffaf plaklar yalnızca ağzınızdayken çalışır. Bu yüzden yemek ve diş fırçalama dışında günün büyük bölümünde takılı kalmaları gerekir. Bazı dişlerin yüzeyine plakların daha iyi tutunması için küçük, diş renginde çıkıntılar yapıştırabiliriz ve gerekirse dişlerin yan yüzeylerinden çok az mine alabiliriz. Tedavi sırasında plan bazen ara düzeltme gerektirebilir; bu normaldir. Sonrasında pekiştirme aparatı kullanımı, diğer yöntemlerde olduğu gibi burada da şarttır.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Dişlerin yüzeyine yapıştırılan küçük çıkıntılar diş rengindedir ve tedavi sonunda temizlenerek çıkarılır. Plakları çıkarıp takmayı ilk randevuda birlikte deneyeceğiz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Görünmez, kimse fark etmez. | ✓ Şeffaf plaklar oldukça az fark edilir; yakından bakıldığında görülebilir. |
| ✗ Canınız istediğinde takarsınız. | ✓ Plaklar yalnızca takılıyken çalışır; günün büyük bölümünde takılı kalmalı. |
| ✗ Şeffaf plakla daha hızlı biter. | ✓ Süre vakanın kendisine bağlıdır; yöntemden çok uyuma bağlıdır. |

# Şeffaf plak isteyen hasta (sınırlı vaka)

**Kime: Hasta** **Ana mesaj: İsteği küçümsemeden dürüst sınır**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Hasta şeffaf plak istiyor; vaka karmaşık (belirgin iskeletsel fark, gömülü diş, ciddi rotasyonlar vb.). Hibrit plan, sabit tedavi veya beklenti yönetimi.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Şeffaf plak isteğinizi çok iyi anlıyorum; görünüm ve konfor açısından önemli avantajları var. Ancak sizin vakanızdaki bazı hareketler, örneğin belirgin dönmüş dişlerin düzeltilmesi ya da çeneler arası ilişkinin değiştirilmesi, şeffaf plaklarla öngörülebilir biçimde yapılması zor hareketler arasında. Bu, yöntemin kötü olduğu anlamına gelmez; sadece sizin vakanız için sınırları olduğu anlamına gelir. Size üç seçenek sunmak istiyorum: tedavinin tamamını sabit braketlerle yapmak, zor bölümü sabit tedaviyle başlatıp sonra şeffaf plaklarla devam etmek ya da şeffaf plakla yalnızca sınırlı bir iyileşmeyi hedeflemek. Her birinin neyi sağlayacağını ve neyi sağlayamayacağını açıkça anlatacağım. Karar sizin; benim görevim seçenekleri dürüstçe ortaya koymak.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Seramik veya diş renginde braketler de sabit tedavinin daha az fark edilen bir seçeneğidir. Hibrit planda önce sabit tedaviyle zor hareketleri yapar, sonra şeffaf plaklara geçeriz.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Şeffaf plak sizin için olmaz. | ✓ Bazı hareketler şeffaf plakla zor; seçenekleri birlikte değerlendirelim. |
| ✗ Plakla da yaparız, bakarız. | ✓ Plakla neyi sağlayabileceğimizi baştan dürüstçe konuşalım. |
| ✗ Teller zaten daha iyi. | ✓ Her yöntemin uygun olduğu vakalar var; sizin vakanıza göre konuşuyoruz. |

# Nüks: dişler yeniden çapraştı

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Suçlamadan, nedeni ve çözümü konuşmak**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Daha önce ortodontik tedavi görmüş; pekiştirme bırakılmış veya kırılmış, dişler kaymış. Sınırlı yeniden tedavi ve uzun süreli pekiştirme.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Dişlerinizin yıllar önce yapılan tedaviden sonra yeniden kaymaya başlaması sık karşılaşılan bir durum. Dişler ömür boyu küçük hareketler yapabilir; pekiştirme aparatı bırakıldığında ya da kırıldığında bu hareketler belirginleşebilir. Bu sizin ya da önceki hekiminizin hatası olmak zorunda değil. Muayenede bugünkü kaymanın ne kadar olduğunu ve kapanışınızın nasıl etkilendiğini değerlendirdik. Çoğu nüks vakasında, tüm ağzı kapsamayan daha kısa ve sınırlı bir tedavi yeterli olabilir. Ancak bu sefer, pekiştirme planını en baştan birlikte konuşalım ve uzun süreli olacağını kabul edelim. Kaymanın kapanışınızı da etkilediği bir durumsa, planı buna göre genişletiriz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Bu kez tedavi sonrası hem sabit lingual pekiştirme hem de gece kullanılan şeffaf pekiştirme plağı birlikte önerilebilir. Pekiştirmenin bakımı ve kontrolleri tedavinin bir parçasıdır.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Önceki tedaviniz kötü yapılmış. | ✓ Dişler zamanla hareket edebilir; bugün ne yapabileceğimize odaklanalım. |
| ✗ Pekiştirmeyi bırakmasaydınız. | ✓ Bu sefer pekiştirme planını en baştan birlikte yapalım. |
| ✗ Bu sefer kesin kalıcı olacak. | ✓ Uzun süreli pekiştirme ile sonucu korumayı hedefleyeceğiz. |

# Sadece ön dişleri isteyen erişkin

**Kime: Hasta (erişkin)** **Ana mesaj: Sınırlı tedavinin sınırları yazılı olsun**

**Klinik çerçeve (hekim için):** Erişkin; yalnızca gülüşte görünen ön dişlerin düzelmesini istiyor. Arka kapanış kabul edilebilir veya hasta kapsamlı tedavi istemiyor. Sınırlı tedavi hedefleri açıkça belirlenmeli.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Sizi en çok rahatsız eden şeyin gülerken görünen ön dişler olduğunu anlıyorum. Sizin vakanızda yalnızca ön dişlere odaklanan sınırlı bir tedavi mümkün olabilir. Bunun avantajları var: genellikle daha kısa sürer ve daha az aparey gerektirir. Ancak sınırlı tedavinin sınırlarını da bilmeniz gerekir. Arka dişlerin kapanışını ve çeneler arasındaki ilişkiyi değiştirmeyeceğiz; bu yüzden bazı sorunlar olduğu gibi kalacak. Ayrıca ön dişleri düzeltmek için yer gerekirse, bunu dişlerin yan yüzeylerinden ölçülü mine alarak sağlayabiliriz. Tedavinin neyi hedeflediğini ve neyi hedeflemediğini yazılı olarak birlikte belirleyelim; böylece sonuçta ikimiz de aynı şeyi bekliyor oluruz.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Sınırlı tedavide ön dişlere braket veya şeffaf plak uygulanabilir. Bazı vakalarda IPR ile küçük bir yer kazanılır. Sınırlı tedavi de pekiştirme gerektirir.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Önlerine bakarız, arkası önemli değil. | ✓ Arka kapanışı değiştirmeyeceğiz; bunun ne anlama geldiğini açıklayayım. |
| ✗ Sınırlı tedavi her şeyi çözer. | ✓ Hedeflerimizi ve sınırları yazılı olarak belirleyelim. |
| ✗ Tam tedavi yapmazsanız pişman olursunuz. | ✓ Kapsamlı tedavinin neler ekleyeceğini anlatayım; seçim sizin. |

# Çene eklemi (TME) yakınması olan hasta

Kime: Hasta | Ana mesaj: Ortodonti TME tedavisi değildir

**Klinik çerçeve (hekim için):** Hasta çene ağrısı, ses veya ağız açmada kısıtlılık bildiriyor. Ortodonti öncesi TME değerlendirmesi ve gerekirse ilgili uzmana yönlendirme; beklenti yönetimi.

### HASTAYA NE SÖYLENİR

«Çene ekleminizde ağrı, ses veya ağız açarken zorlanma gibi bir şikâyetiniz olduğunu söylediniz; bunu ciddiye alıyorum. Ortodontik tedavinin çene eklemi sorunlarını tedavi etmek için tek başına bir yöntem olmadığını açıkça belirtmek isterim. Bu yüzden önce eklem şikâyetinizi ayrıca değerlendirmek, gerekirse bu alanda çalışan bir uzmanın görüşünü almak istiyorum. Şikâyetiniz kontrol altındaysa, dişlerinizin diziliş ve kapanışı için ortodontik tedaviyi planlayabiliriz. Tedavi sırasında eklem şikâyetinizde değişiklik olursa bunu hemen bana söylemenizi isterim; plana ara verebilir veya değiştirebiliriz. Başlangıçtaki durumu kayıt altına alarak her kontrolde karşılaştıracağız.»

### ÇEKİM / APAREY GEREKİYORSA NASIL ANLATILIR

«Tedavi boyunca eklem şikâyetinizi her kontrolde soracağım ve not edeceğim. Gerekirse kuvvetleri azaltır veya tedaviye ara veririz. Gece kullanılan bir plak gerekirse bunu ilgili uzmanla birlikte planlarız.»

### KAÇINILACAK İFADELER

| SÖYLEMEYİN | BUNUN YERİNE |
|---|---|
| ✗ Tellerle çene ağrınız geçer. | ✓ Ortodonti eklem sorunlarının tedavisi değildir; eklemi ayrıca değerlendirelim. |
| ✗ Kapanışınız bozuk, ağrı ondan. | ✓ Ağrının birden fazla nedeni olabilir; bunu ayrıca değerlendirmemiz gerekiyor. |
| ✗ Önemli bir şey değil. | ✓ Şikâyetinizi kayıt altına alıp her kontrolde takip edeceğim. |

BÖLÜM 8

# Sunum Sonrası Kontrol Listesi

Hasta veya ebeveyn kliniğinizden çıkmadan önce bu listeye bakın.

## Sunumdan sonra

- [ ] Hastanın ana şikâyetini ve beklentisini planla eşleştirdim.
- [ ] Bulguları teknik terim kullanmadan, tarif ederek anlattım.
- [ ] Önerdiğim planı ve nedenini söyledim.
- [ ] Diğer seçenekleri, izlem veya tedavi etmeme seçeneği dahil, anlattım.
- [ ] Çekim, mini vida, aparey veya cerrahi gerekiyorsa ayrıca ve sakin bir dille açıkladım.
- [ ] Süreyi yaklaşık bir aralık olarak verdim; kesin süre söylemedim.
- [ ] Hastanın görevlerini (hijyen, elastik, aparey, kontrol, pekiştirme) tek tek saydım.
- [ ] Hastaya anlattıklarımı kendi cümleleriyle özetlemesini istedim.
- [ ] Yazılı tek sayfalık planı verdim.
- [ ] Kliniğimizin kullandığı onam formunu ve karar için zaman tanıdığımı belirttim.
- [ ] Bir sonraki adımı (kayıt, konsültasyon, kontrol veya başlangıç randevusu) netleştirdim.

| HASTADAN GELEN SİNYAL | NE YAPMALI |
|---|---|
| Sessizleşti, soru sormuyor | «Size en çok endişe veren kısım hangisi?» diye açık uçlu sorun. |
| Hemen fiyatı soruyor | Önce planın neyi kapsadığını özetleyin; ücret bilgisini kliniğinizin standart yöntemiyle verin. |
| «Düşüneyim» diyor | Bu sağlıklı bir yanıttır. Yazılı planı verin ve sonraki adım için tarih önerin. |
| Ebeveynler farklı düşünüyor | İki tarafın da kaygısını ayrı ayrı özetleyin; ortak noktadan başlayın (Bonus 3). |

| HASTADAN GELEN SİNYAL | NE YAPMALI |
|---|---|
| Başka hekimin önerisini aktarıyor | Yorum yapmadan iki planın hedeflerini karşılaştırın (Bonus 2, ilgili soru). |

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

# Sonraki adım

Planı hastaya yazılı vermek için **Bonus 1 · Tedavi Planını Tek Sayfada Anlatma Şablonları** dosyasını açın. Hastanın zor sorularına hazırlanmak için **Bonus 2 · Hastaların En Sık Sorduğu 30 Zor Soru ve Cevabı**. Planın kendisini kurmak için Başucu Kitabı'ndaki **Modül 03 Klinik Planlama: Problem Listesinden Mekaniğe**.